

TD Pathologies digestives — L2

CHR ABOBO

Formation en Sciences Infirmières / Médicales

TRAVAUX DIRIGÉS (TD)

Soins Infirmiers dans les Pathologies Digestives

Questions Objectives — QCS (Questions à Choix Simple) et QCM (Questions à Choix Multiple)

15 QCS + 15 QCM par chapitre — Document sans corrigé

Chapitres couverts :

Chapitre 1 — Les Hépatites

Chapitre 2 — Les Cirrhoses

Chapitre 3 — Cancers Primitifs du Foie

Chapitre 4 — Les Ulcères Gastro-Duodénaux (UGD)

Chapitre 5 — La Lithiase Biliaire (Cholélithiase)

Sommaire

Chapitre 1 — Les Hépatites

Série A — QCS (Questions à Choix Simple)

Consigne : Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Entourez ou cochez la bonne réponse.

1. La transmission de l'hépatite A se fait principalement par voie :

- A. Parentérale
- B. Orale
- C. Sexuelle
- D. Transplacentaire

2. Le virus de l'hépatite B se transmet essentiellement par voie :

- A. Orale
- B. Parentérale
- C. Aérienne
- D. Digestive

3. L'ictère est dû à l'augmentation du taux sérique de :

- A. Urée
- B. Bilirubine
- C. Créatinine
- D. Glucose

4. La phase d'incubation de l'hépatite B dure :

- A. 15 jours
- B. 1 à 4 mois
- C. 24 heures
- D. 1 semaine

5. L'hépatite chronique est définie par une évolution anormale des transaminases pendant au moins :

- A. 1 mois

- B. 3 mois
- C. 6 mois
- D. 1 an

6. La cause la plus fréquente de dysfonctionnement hépatique est :

- A. Virale
- B. La malnutrition
- C. Médicamenteuse
- D. Parasitaire

7. Dans l'hépatite virale, le taux de transaminases est généralement augmenté de plus de :

- A. 2 fois la normale
- B. 5 fois la normale
- C. 10 fois la normale
- D. 20 fois la normale

8. La voie de contamination mère-enfant de l'hépatite est appelée voie :

- A. Orale
- B. Verticale
- C. Rituelle
- D. Parentérale

9. Le meilleur moyen de prévention de l'hépatite B est :

- A. Les antibiotiques
- B. La vaccination
- C. Le repos
- D. Le régime sans sel

10. L'hépatite alcoolique aiguë peut ressembler à une poussée de :

- A. Pancréatite
- B. Cholécystite
- C. Gastrite
- D. Appendicite

11. Le vaccin contre l'hépatite B confère l'immunité après la :

- A. 1ère injection
- B. 2ème injection
- C. 3ème injection
- D. 4ème injection

12. La complication majeure de l'hépatite chronique avec évolution vers la fibrose est :

- A. L'ascite
- B. La cirrhose
- C. L'ictère
- D. La fièvre

13. Le régime alimentaire conseillé chez le patient hépatique doit être :

- A. Riche en graisse
- B. Riche en glucides et pauvre en graisse

C. Pauvre en protides

D. Riche en sel

14. L'hépatite B est une maladie :

A. Bénigne sans déclaration

B. À déclaration obligatoire

C. Non contagieuse

D. Sans risque de chronicité

15. Le contrôle biologique après hépatite doit être assuré tous les :

A. 1 mois la 1ère année

B. 3 mois la 1ère année

C. 1 an la 1ère année

D. Jamais

Série B — QCM (Questions à Choix Multiple)

Consigne : Pour chaque question, plusieurs réponses peuvent être correctes. Cochez toutes les réponses exactes.

1. Parmi les voies de contamination des hépatites virales, lesquelles sont citées dans le cours ?

A. Orale

B. Parentérale

C. Sexuelle

D. Rituelle

E. Respiratoire

2. Quels virus sont responsables des hépatites les plus fréquentes ?

A. Virus A

B. Virus B

C. Virus C

D. Virus D

E. Virus de la rage

3. Parmi les signes essentiels de l'hépatite alcoolique aiguë, lesquels retrouve-t-on ?

A. Ictère

B. Vomissement

C. Fièvre

D. Hépatosplénomégalie douloureuse

E. Toux

4. Quels sont les signes paracliniques de l'hépatite alcoolique aiguë ?

A. Augmentation des transaminases

B. Hyperleucocytose à PNN

C. Anémie hémolytique

D. Hypoglycémie

E. Échographie éliminant une lithiase

5. Quelles sont les phases de la forme symptomatique typique de l'hépatite virale ?

A. Phase d'incubation

B. Phase pré-ictérique

- C. Phase ictérique
 - D. Phase de rémission immédiate
 - E. Phase de convalescence
6. Parmi les complications possibles de l'hépatite chronique, lesquelles sont citées ?
- A. Cirrhose
 - B. Carcinome hépatocellulaire
 - C. Manifestations extra-hépatiques
 - D. Guérison spontanée systématique
 - E. Aucune
7. Quels examens complémentaires permettent le diagnostic d'une hépatite ?
- A. Bilan hépatique (transaminases)
 - B. Sérologie virale
 - C. Échographie
 - D. Biopsie hépatique
 - E. Radiographie du thorax
8. Parmi les mesures prophylactiques contre l'hépatite virale, lesquelles sont recommandées ?
- A. Isoler le malade en chambre individuelle
 - B. Utiliser du matériel à usage unique
 - C. Désinfecter les mains avant et après les soins
 - D. Partager le thermomètre entre patients
 - E. Éviter les rapports sexuels non protégés
9. Quels traitements antiviraux sont cités pour l'hépatite chronique ?
- A. Interféron
 - B. Ribavirine
 - C. Corticoïdes
 - D. Paracétamol
 - E. Immunosuppresseurs
10. Parmi les éléments de surveillance du malade atteint d'hépatite, lesquels sont mentionnés ?
- A. Prendre la tension 2 fois/jour
 - B. Noter la diurèse
 - C. Observer le jaunissement des téguments
 - D. Ignorer les troubles de la conscience
 - E. Surveiller le transit intestinal
11. Quelles sont les causes médicamenteuses pouvant entraîner une hépatite ?
- A. Rimifon
 - B. Largatil
 - C. Paracétamol en abus
 - D. Vitamine C
 - E. Insuline
12. Parmi les signes cliniques de l'hépatite chronique, lesquels sont décrits ?
- A. Asthénie

- B. Subictère
 - C. Amaigrissement
 - D. Manifestations extra-digestives
 - E. Absence totale de symptômes
13. Quels sont les éléments du régime alimentaire conseillés chez le patient hépatique ?
- A. Riche en glucides
 - B. Riche en protides
 - C. Pauvre en graisse
 - D. Suppression de l'alcool
 - E. Riche en graisses animales
14. Parmi les soins infirmiers à l'accueil du malade hépatique, lesquels sont cités ?
- A. Isoler le malade
 - B. Préparer le matériel d'usage individuel
 - C. Préparer une feuille de surveillance
 - D. Administrer immédiatement une chimiothérapie
 - E. Prélever le sang à jeun pour bilan
15. Quelles complications peuvent survenir lors d'une hépatite alcoolique aiguë ?
- A. Coma hépatique
 - B. Ascite
 - C. Hémorragie digestive
 - D. Pancréatite aiguë
 - E. Guérison sans séquelle dans 100% des cas

Chapitre 2 — Les Cirrhoses

Série A — QCS (Questions à Choix Simple)

Consigne : Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Entourez ou cochez la bonne réponse.

1. La cirrhose est caractérisée par un bouleversement de :
- A. La fonction rénale
 - B. L'architecture hépatique
 - C. La fonction pulmonaire
 - D. La fonction cardiaque
2. La cause la plus fréquente de cirrhose dans le cours est :
- A. Virale
 - B. Alcoolique
 - C. Médicamenteuse
 - D. Métabolique
3. L'alcool est responsable de la cirrhose alcoolique dans environ :
- A. 30% des cas
 - B. 50% des cas
 - C. 80% des cas
 - D. 100% des cas
4. La cirrhose évolue schématiquement en :

- A. Un seul stade
 - B. Deux stades
 - C. Trois stades
 - D. Quatre stades
5. Le stade de cirrhose compensée précède le stade de cirrhose :
- A. Guérie
 - B. Décompensée
 - C. Cancéreuse
 - D. Aiguë
6. Le signe annonciateur de l'ascite (« les vents annoncent la pluie ») est :
- A. L'ictère
 - B. Le météorisme abdominal
 - C. La fièvre
 - D. La diarrhée
7. La ponction d'ascite retrouve généralement :
- A. Un exsudat purulent
 - B. Un transsudat avec liquide citrin
 - C. Du sang pur
 - D. De la bile
8. La complication la plus fréquente de la cirrhose est :
- A. Le syndrome oedémato-ascitique
 - B. Le cancer du poumon
 - C. L'insuffisance rénale aiguë
 - D. La pancréatite
9. Les hémorragies digestives de la cirrhose sont le plus souvent dues à la rupture :
- A. D'un ulcère gastrique
 - B. De varices œsophagiennes
 - C. D'un polype colique
 - D. D'une hémorroïde
10. Sans sevrage alcoolique, l'évolution de la cirrhose se fait vers la mort en moins de :
- A. 6 mois
 - B. 1 an
 - C. 2 ans
 - D. 10 ans
11. Le traitement de l'ascite en cas de cirrhose repose en partie sur un régime :
- A. Riche en sel
 - B. Désodé ou hyposodé
 - C. Riche en graisse
 - D. Hyperprotidique
12. Dans l'encéphalopathie hépatique, l'apport protidique doit être :
- A. Augmenté

B. Diminué à moins de 20 g/24h

C. Supprimé totalement

D. Doublé

13. Le lactulose est utilisé dans l'encéphalopathie hépatique pour :

A. Augmenter le PH colique

B. Réduire la production de substances neurotoxiques intestinales

C. Traiter l'ascite

D. Stopper l'hémorragie

14. La cirrhose pigmentaire est associée à une surcharge en :

A. Cuivre

B. Fer

C. Zinc

D. Calcium

15. La maladie de Wilson est caractérisée par une accumulation de :

A. Fer

B. Cuivre

C. Plomb

D. Zinc

Série B — QCM (Questions à Choix Multiple)

Consigne : Pour chaque question, plusieurs réponses peuvent être correctes. Cochez toutes les réponses exactes.

1. Quels sont les facteurs adjuvants de la cirrhose alcoolique ?

A. Le terrain

B. Une ration alimentaire insuffisante

C. Le tabac uniquement

D. L'âge avancé uniquement

E. Une carence protidique

2. Parmi les troubles digestifs de la période pré-ascitique, lesquels sont cités ?

A. Nausées

B. Ballonnement

C. Alternance diarrhée/constipation

D. Dégoût pour les viandes et graisses

E. Constipation isolée définitive

3. Quels sont les troubles nerveux observés dans la cirrhose compensée ?

A. Crises de sudation nocturnes

B. Cauchemars

C. Crampes musculaires

D. Tremblement des mains

E. Paralysie définitive

4. Parmi les signes de la période ascitique, lesquels sont décrits ?

A. Augmentation du volume de l'abdomen

B. Amaigrissement du visage

- C. Circulation collatérale abdominale
 - D. Splénomégalie
 - E. Absence totale de symptômes
5. Quelles sont les causes de décompensation de la cirrhose ?
- A. Ingestion plus importante d'alcool
 - B. Carence alimentaire en protide
 - C. Surmenage
 - D. Maladie infectieuse
 - E. Régime hyposodé bien suivi
6. Parmi les signes de la cirrhose décompensée, lesquels sont cités ?
- A. Ascite et œdème des membres inférieurs
 - B. Oligurie
 - C. Ictère
 - D. Hémorragie
 - E. Amélioration de l'état général
7. Quels médicaments sont utilisés dans le traitement curatif de la cirrhose ?
- A. Diurétiques
 - B. Lipotropes
 - C. Vitamines du groupe B
 - D. Vitamine K parentérale
 - E. Antibiotiques systématiques
8. Parmi les variétés de cirrhoses non alcooliques citées, lesquelles trouve-t-on ?
- A. Cirrhose pigmentaire
 - B. Cirrhose cardiaque
 - C. Cirrhose cholestatique
 - D. Cirrhose virale
 - E. Cirrhose allergique
9. Quels sont les éléments de diagnostic clinique de la cirrhose alcoolique ?
- A. Association de signes d'éthylisme
 - B. Hépatomégalie
 - C. Varicosité des pommets
 - D. Tremblement de la langue et des mains
 - E. Absence d'hépatomégalie
10. Parmi les rôles infirmiers dans les soins de la cirrhose, lesquels sont mentionnés ?
- A. Peser le client tous les jours
 - B. Restreindre le sodium
 - C. Administrer les diurétiques selon prescription
 - D. Ignorer les ingesta et excréta
 - E. Noter la circonférence de l'abdomen
11. Quels sont les signes de l'hématémèse à surveiller selon le tableau de soins ?
- A. Anxiété, plénitude gastrique

- B. Signes d'hémorragie et de choc
 - C. Signes vitaux à intervalles fréquents
 - D. Hydratation excessive forcée
 - E. Hygiène buccale méticuleuse
12. Parmi les examens biologiques principaux des cirrhoses, lesquels sont cités ?
- A. Transaminases (GOT, GPT)
 - B. Gamma GT
 - C. Électrophorèse des protéines
 - D. Glycémie post-prandiale
 - E. Bilirubine
13. Quelles techniques d'imagerie sont utilisées pour le diagnostic de cirrhose ?
- A. Fibroscopie œsogastroduodénale
 - B. Échographie
 - C. Tomodensitométrie
 - D. Artériographie
 - E. Radiographie du crâne
14. Parmi les soins infirmiers en cas d'ictère chez le cirrhotique, lesquels sont recommandés ?
- A. Soulager le prurit par des soins de peau
 - B. Garder les ongles courts
 - C. Masser avec des lotions émollientes
 - D. Ignorer les plaintes du client
 - E. Bains sans savon
15. Quels facteurs favorisent l'apparition de l'ascite chez le cirrhotique ?
- A. Hémorragie digestive
 - B. Accident infectieux
 - C. Poussée d'hépatite alcoolique
 - D. Régime sans sel bien suivi
 - E. Météorisme précédent

Chapitre 3 — Cancers Primitifs du Foie

Série A — QCS (Questions à Choix Simple)

Consigne : Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Entourez ou cochez la bonne réponse.

1. Le cancer primitif du foie se développe habituellement sur :
- A. Un foie sain
 - B. Une cirrhose
 - C. Un rein
 - D. Une rate
2. Le CPF est aussi appelé :
- A. Cholangiome
 - B. Carcinome hépatocellulaire
 - C. Adénome rénal
 - D. Lymphome

3. En Afrique, la cause la plus fréquente du CPF est :

- A. Virale
- B. Alcoolique
- C. Médicamenteuse
- D. Métabolique

4. L'aflatoxine est une toxine qui contamine :

- A. Le riz
- B. Les arachides
- C. Le poisson
- D. Le lait

5. La forme histologique la plus fréquente du CPF (80%) est :

- A. Le cholangiome malin
- B. L'hépatome malin
- C. Le lymphome
- D. Le sarcome

6. Le marqueur tumoral utilisé pour le dépistage du CHC est :

- A. Le CA 19-9
- B. L'alpha-fœtoprotéine
- C. Le PSA
- D. La CRP

7. Le seuil significatif de l'alpha-fœtoprotéine pour le diagnostic est supérieur à :

- A. 50 ng/ml
- B. 100 ng/ml
- C. 500 ng/ml
- D. 1000 ng/ml

8. Le dépistage systématique du CHC chez le cirrhotique repose sur une échographie et une alpha-fœtoprotéine tous les :

- A. 1 mois
- B. 3 mois
- C. 6 mois
- D. 1 an

9. Le CPF représente en Afrique noire la :

- A. 3ème cause de décès par cancer
- B. 1ère cause de décès par cancer
- C. Cause la plus rare de cancer
- D. Cause exclusivement infantile

10. Le délai de survie à partir du 1er symptôme du CPF dépasse exceptionnellement :

- A. 1 mois
- B. 6 mois
- C. 5 ans
- D. 10 ans

11. Le traitement curatif de référence du CPF est :

- A. La chimiothérapie systémique
- B. La transplantation hépatique
- C. La radiothérapie
- D. Les antibiotiques

12. La radiothérapie et la chimiothérapie systémique dans le traitement du CHC :

- A. Sont les traitements de référence
- B. N'ont pas de place dans le traitement
- C. Sont curatives à 100%
- D. Remplacent la chirurgie

13. Les métastases du CPF se localisent fréquemment au niveau :

- A. Des poumons et des os
- B. Uniquement de la peau
- C. Uniquement des yeux
- D. Jamais aux ganglions

14. Une technique de diagnostic positif du CPF avec un taux de réussite de 85% est :

- A. La radiographie simple
- B. La laparoscopie et les biopsies
- C. L'ECG
- D. La spirométrie

15. Le cancer secondaire du foie est appelé aussi :

- A. Cancer primitif
- B. Métastase
- C. Lymphome
- D. Sarcome primaire

Série B — QCM (Questions à Choix Multiple)

Consigne : Pour chaque question, plusieurs réponses peuvent être correctes. Cochez toutes les réponses exactes.

1. Parmi les causes du CPF en Europe et Amérique du Nord, lesquelles sont citées ?

- A. Cirrhose alcoolique
- B. Cirrhose d'origine virale
- C. Hémochromatose
- D. Carence vitaminique
- E. Aflatoxine

2. Quels sont les facteurs de carcinogenèse hépatique mentionnés ?

- A. Virus de l'hépatite B et C
- B. Consommation d'alcool
- C. Prédispositions génétiques
- D. Carcinogènes chimiques (aflatoxine)
- E. Carence en fer isolée

3. Parmi les 5 tableaux cliniques du cancer du foie cités, lesquels trouve-t-on ?

- A. Foie tumoral
- B. Foie fébrile

- C. Foie douloureux
 - D. Foie ictérique
 - E. Foie asymptomatique
4. Quels sont les signes cliniques évocateurs du cancer du foie sur foie non cirrhotique ?
- A. Asthénie
 - B. Amaigrissement
 - C. Douleur du foie irradiant en arrière et en haut
 - D. Possibilité de fièvre
 - E. Absence totale de symptômes
5. Parmi les examens paracliniques du CPF, lesquels sont cités ?
- A. Scintigraphie
 - B. Artériographie
 - C. Laparoscopie et biopsies
 - D. Échographie abdominale
 - E. Électroencéphalogramme
6. Quels sont les signes du syndrome de cholestase recherchés dans le CHC ?
- A. Élévation de la phosphatase alcaline
 - B. Élévation de la bilirubine
 - C. Élévation de la gamma-glutyl-transférase
 - D. Hypoglycémie isolée
 - E. Aucun signe biologique
7. Parmi les éléments du syndrome paranéoplasique cités, lesquels trouve-t-on ?
- A. Polyglobulie
 - B. Hypercalcémie
 - C. Hypoglycémie
 - D. Anémie macrocytaire
 - E. Leucémie
8. Quelles sont les complications du CPF à un stade avancé ?
- A. Hémopéritoïnes aiguës
 - B. Douleur abdominale intense
 - C. Hémorragie intense avec collapsus
 - D. Abscès du foie
 - E. Guérison spontanée
9. Parmi les traitements du cancer secondaire (métastase), lesquels sont cités ?
- A. Chimiothérapie
 - B. Thérapies ciblées et immunothérapie
 - C. Hormonothérapie
 - D. Radiothérapie et chirurgie
 - E. Jeûne thérapeutique seul
10. Quels organes sont des sièges fréquents de cancers secondaires selon le texte ?
- A. Le foie (à partir du cancer du côlon)

- B. Les os (à partir du cancer de la prostate)
- C. Le cerveau (à partir du cancer du poumon)
- D. Les poumons (à partir du cancer du sein)
- E. Aucun organe n'est concerné

11. Parmi les conditions requises pour envisager une exérèse chirurgicale du CPF, lesquelles sont citées ?

- A. Absence de cirrhose
- B. Absence de métastase évidente
- C. Tumeur localisable et réséquable
- D. Présence de cirrhose sévère
- E. Hépatectomie partielle réglée possible

12. Quelles techniques de diagnostic sont utilisées pour différencier un cancer primitif d'un cancer secondaire ?

- A. Anatomopathologie
- B. Immunohistochimie
- C. FISH (hybridation in situ en fluorescence)
- D. Radiographie standard seule
- E. Aucune technique fiable n'existe

13. Parmi les rôles de l'infirmier dans la prise en charge du CPF, lesquels sont cités ?

- A. Soins d'hygiène et de propreté
- B. Surveillance du traitement et des résultats des examens
- C. IEC/CCC
- D. Prescription des chimiothérapies
- E. Prise régulière des constantes

14. Quels sont les buts du traitement du CPF ?

- A. Améliorer la survie
- B. Prévenir la récurrence tumorale
- C. Améliorer la qualité de vie du malade
- D. Garantir une guérison à 100%
- E. Aucun objectif thérapeutique défini

15. Parmi les armes thérapeutiques palliatives citées pour le CPF, lesquelles trouve-t-on ?

- A. Alcoolisation/acétisation
- B. Radiofréquence
- C. Chimio-embolisation
- D. Transplantation hépatique
- E. Hépatectomie totale curative

Chapitre 4 — Les Ulcères Gastro-Duodénaux (UGD)

Série A — QCS (Questions à Choix Simple)

Consigne : Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Entourez ou cochez la bonne réponse.

1. L'ulcère gastroduodénal atteint la couche :

- A. Muqueuse uniquement

- B. Musculaire
 - C. Séreuse uniquement
 - D. Sous-cutanée
2. L'ulcère du bulbe est plus fréquent chez :
- A. La femme
 - B. L'homme
 - C. L'enfant
 - D. Le nourrisson
3. Helicobacter pylori est retrouvé dans l'ulcère duodénal dans environ :
- A. 9 fois sur 10
 - B. 1 fois sur 10
 - C. Jamais
 - D. 5 fois sur 10
4. La prise d'AINS augmente le risque d'ulcère gastroduodénal d'environ :
- A. 1 à 2 fois
 - B. 3 à 5 fois
 - C. 10 fois
 - D. Aucune augmentation
5. La douleur du syndrome ulcéreux typique est calmée par :
- A. Le jeûne
 - B. La prise alimentaire
 - C. L'effort physique
 - D. La position allongée
6. La douleur ulcéreuse typique survient après le repas dans un délai de :
- A. 1 à 5 heures
 - B. Immédiatement
 - C. 24 heures
 - D. 1 semaine
7. Le risque de cancérisation de l'ulcère concerne uniquement :
- A. L'ulcère duodénal
 - B. L'ulcère gastrique
 - C. Les deux également
 - D. Aucun des deux
8. La suspicion d'ulcère perforé est une contre-indication à :
- A. L'échographie
 - B. L'endoscopie digestive haute
 - C. La radiographie
 - D. La prise de sang
9. La sténose ulcéreuse se situe le plus souvent au niveau :
- A. Pylorique ou duodénal
 - B. Œsophagien

C. Colique

D. Rectal

10. Le traitement d'éradication d'*Helicobacter pylori* associe un anti-sécrétoire à :

A. Une mono-antibiothérapie

B. Une bi-antibiothérapie

C. Aucun antibiotique

D. Une corticothérapie

11. La durée du traitement anti-sécrétoire après éradication pour l'ulcère duodénal est de :

A. 1 semaine

B. 3 semaines

C. 4 à 6 semaines

D. 3 mois

12. La durée du traitement anti-sécrétoire pour l'ulcère gastrique est de :

A. 1 semaine

B. 2 semaines

C. 4 à 6 semaines

D. 6 mois

13. En cas d'hémorragie ulcéreuse, le patient doit être mis :

A. À l'alimentation normale

B. À jeun

C. Sous perfusion de glucose uniquement

D. En ambulatoire

14. Le facteur favorisant reconnu uniquement en réanimation est :

A. L'âge

B. Le stress

C. L'alcool

D. Le tabac

15. Une endoscopie de contrôle systématique après traitement est recommandée pour :

A. Tous les ulcères duodénaux

B. Les ulcères gastriques

C. Aucun ulcère

D. Uniquement en l'absence de douleur

Série B — QCM (Questions à Choix Multiple)

Consigne : Pour chaque question, plusieurs réponses peuvent être correctes. Cochez toutes les réponses exactes.

1. Quels sont les facteurs protecteurs de la muqueuse gastrique cités ?

A. Sécrétion de prostaglandines

B. Production de mucus de surface

C. Intégrité de l'épithélium de surface

D. Vascularisation de la muqueuse

E. Sécrétion d'ions H⁺

2. Parmi les facteurs d'agression de la muqueuse gastrique, lesquels sont cités ?

- A. Sécrétion d'ions H⁺
 - B. Infection à *Helicobacter pylori*
 - C. Prise d'AINS
 - D. Tabagisme
 - E. Sécrétion de bicarbonates
3. Quels sont les facteurs favorisant de l'ulcère gastroduodénal ?
- A. L'âge
 - B. La consommation d'alcool
 - C. Le tabagisme
 - D. L'infection à *Helicobacter pylori*
 - E. La pratique sportive régulière
4. Parmi les caractéristiques du syndrome ulcéreux typique, lesquelles sont citées ?
- A. Douleur épigastrique
 - B. Type crampe ou faim douloureuse
 - C. Calmée par la prise alimentaire
 - D. Caractère post-prandial
 - E. Douleur permanente non rythmée
5. Quels signes retrouve-t-on en cas d'hémorragie digestive occulte sur ulcère ?
- A. Pâleur cutanéomuqueuse
 - B. Tachycardie
 - C. Anémie microcytaire hypochrome
 - D. Dyspnée d'effort
 - E. Hyperthermie majeure constante
6. Parmi les signes du choc hypovolémique en cas d'hémorragie ulcéreuse massive, lesquels sont cités ?
- A. Tachycardie
 - B. Hypotension
 - C. Sueurs, marbrures cutanées
 - D. Pouls rapide et filant
 - E. Bradycardie franche
7. Quels sont les signes cliniques d'une péritonite par perforation ulcéreuse ?
- A. Douleur épigastrique brutale et diffuse
 - B. Arrêt des matières et des gaz
 - C. Contracture abdominale
 - D. Pneumopéritoine à la percussion
 - E. Absence de douleur
8. Parmi les examens d'imagerie utiles au diagnostic d'ulcère perforé, lesquels sont cités ?
- A. Abdomen sans préparation (ASP)
 - B. Tomodensitométrie
 - C. Transit œso-gastro-duodénal systématique
 - D. Radiographie standard de l'abdomen
 - E. IRM cérébrale

9. Quelles sont les techniques de diagnostic de l'infection à *Helicobacter pylori* ?

- A. Mise en culture
- B. Examen anatomopathologique des biopsies
- C. Tests respiratoires (Helikit)
- D. Dosage de la glycémie
- E. NFS seule

10. Parmi les objectifs du traitement de l'ulcère, lesquels sont cités ?

- A. Soulager rapidement le patient
- B. Accélérer la cicatrisation spontanée
- C. Prévenir les récurrences et complications
- D. Provoquer une cicatrice définitive immédiate
- E. Aucun objectif spécifique

11. Quels médicaments composent la trithérapie d'éradication d'*Helicobacter pylori* ?

- A. Un anti-sécrétoire à double dose
- B. Amoxicilline
- C. Clarithromycine ou métronidazole
- D. Corticoïdes
- E. Paracétamol

12. Parmi les mesures de prise en charge d'une hémorragie ulcéreuse, lesquelles sont citées ?

- A. Hospitalisation en soins intensifs
- B. Mise à jeun du patient
- C. Pose de deux voies veineuses
- D. Alimentation normale immédiate
- E. Oxygénothérapie

13. Quels examens biologiques sont réalisés en urgence en cas d'hémorragie ulcéreuse ?

- A. Groupage ABO rhésus
- B. NFS
- C. Ionogramme, urée, créatinine
- D. Glycémie post-prandiale uniquement
- E. Bilan hépatique complet uniquement

14. Parmi les éléments de prise en charge d'une perforation digestive avec péritonite, lesquels sont cités ?

- A. Patient à jeun strict
- B. Bilan préopératoire en urgence
- C. Aspiration gastrique continue
- D. Antibiothérapie à large spectre
- E. Alimentation orale immédiate

15. Quelles complications de l'ulcère gastroduodénal sont décrites dans le cours ?

- A. Hémorragie digestive
- B. Perforation digestive
- C. Sténose
- D. Cancérisation

E. Embolie pulmonaire systématique

Chapitre 5 — La Lithiase Biliaire (Cholélithiase)

Série A — QCS (Questions à Choix Simple)

Consigne : Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Entourez ou cochez la bonne réponse.

1. La lithiase biliaire se rencontre le plus fréquemment chez :

- A. L'homme
- B. La femme
- C. L'enfant
- D. Le nouveau-né

2. La cholélithiase se définit par la présence de calculs dans :

- A. Le foie
- B. La vésicule biliaire
- C. Le pancréas
- D. Le rein

3. Si les calculs sont situés dans le cholédoque, on parle de :

- A. Cholécystite
- B. Cholédo-lithiase
- C. Hépatite
- D. Cirrhose

4. La colique hépatique est typiquement :

- A. Une douleur sourde permanente
- B. Une douleur aiguë paroxystique de type crampe
- C. Une douleur thoracique
- D. Une douleur articulaire

5. Le siège typique de la douleur de la colique hépatique est :

- A. La fosse iliaque gauche
- B. L'hypochondre droit et l'épigastre
- C. La région lombaire
- D. La région ombilicale

6. L'irradiation typique de la colique hépatique se fait vers :

- A. L'épaule droite et entre les omoplates
- B. Le membre inférieur gauche
- C. Le cou
- D. Le genou

7. La présence de l'ictère dans la lithiase biliaire dépend :

- A. Du sexe du patient
- B. Du siège du calcul obstruant le canal cystique
- C. De l'âge du patient
- D. De la pression artérielle

8. L'examen de référence confirmant le diagnostic positif de la lithiase biliaire est :

- A. La radiographie standard

- B. L'échographie
- C. Le scanner cérébral
- D. L'ECG

9. La taille limite des calculs détectables à l'échographie est d'environ :

- A. 2 mm
- B. 2 cm
- C. 10 cm
- D. 50 mm

10. La cholécystite calculueuse aiguë se manifeste par une température autour de :

- A. 36°C
- B. 37°C
- C. 39 à 39,5°C
- D. 41°C

11. Le blocage de la voie biliaire principale par un calcul peut entraîner le décès dans :

- A. 0% des cas
- B. 15 à 20% des cas
- C. 50% des cas
- D. 100% des cas

12. La pancréatite aiguë peut survenir par obstruction du canal de :

- A. Cystique
- B. Wirsung
- C. Cholédoque uniquement
- D. Hépatique

13. Le régime conseillé dans la lithiase biliaire doit éviter les aliments riches en :

- A. Glucides
- B. Cholestérol
- C. Fibres
- D. Eau

14. En cas de colique hépatique, le malade doit être mis :

- A. À l'alimentation normale
- B. À jeun
- C. Sous antibiotiques uniquement
- D. En position debout

15. La cholécystectomie s'impose en urgence en cas de complication associant fièvre et :

- A. Anémie
- B. Hyperleucocytose importante
- C. Hypoglycémie
- D. Hypotension isolée

Série B — QCM (Questions à Choix Multiple)

Consigne : Pour chaque question, plusieurs réponses peuvent être correctes. Cochez toutes les réponses exactes.

1. Parmi les facteurs favorisant la lithiase biliaire, lesquels sont cités ?

- A. Le sexe féminin
- B. L'âge avancé
- C. Les grossesses nombreuses
- D. L'obésité
- E. Le jeûne prolongé répété

2. Quels éléments peuvent déclencher une crise de colique hépatique ?

- A. Les émotions
- B. Un repas copieux
- C. Le chocolat
- D. Un épisode de vie génitale
- E. Le repos complet

3. Parmi les troubles provoqués par la lithiase, lesquels sont décrits ?

- A. Pesanteur de l'épigastre droit
- B. Ballonnement abdominal
- C. Éructations
- D. Vomissements
- E. Absence totale de troubles digestifs

4. Quelles sont les caractéristiques de la colique hépatique selon le cours ?

- A. Caractère aigu paroxystique
- B. Type crampe
- C. Siège hypochondre droit et épigastre
- D. Irradiation vers l'épaule droite
- E. Douleur calmée immédiatement par l'alimentation

5. Parmi les signes cliniques associés à la cholélithiase, lesquels sont cités ?

- A. Colique hépatique
- B. Nausée
- C. Vomissement
- D. Intolérance aux graisses
- E. Absence de tout symptôme dans tous les cas

6. Quelles sont les complications possibles de la lithiase biliaire ?

- A. Cholécystite calculueuse aiguë
- B. Lithiase du canal cholédoque
- C. Ictère intense
- D. Pancréatite aiguë
- E. Guérison spontanée systématique

7. Parmi les diagnostics différentiels de la lithiase biliaire, lesquels sont cités ?

- A. Appendicite aiguë
- B. Pancréatite aiguë
- C. Colique néphrétique
- D. Infarctus du myocarde
- E. Otite moyenne

8. Quels examens paracliniques permettent le diagnostic positif de la lithiase biliaire ?
- A. Radiographie de la vésicule
 - B. Tubage duodénal
 - C. Échographie
 - D. Exploration des fonctions hépatiques
 - E. Électroencéphalogramme
9. Parmi les éléments du traitement général de la lithiase bien supportée, lesquels sont cités ?
- A. Repos
 - B. Régime pauvre en cholestérol
 - C. Cures thermales
 - D. Médication antiseptique
 - E. Chirurgie systématique immédiate
10. Quels gestes infirmiers sont recommandés en cas de colique hépatique ?
- A. Mettre le malade à jeun
 - B. Appliquer des compresses chaudes sur la région vésiculaire
 - C. Administrer des antispasmodiques
 - D. Administrer des antalgiques
 - E. Alimentation forcée immédiate
11. Parmi les rôles de l'infirmier avant le traitement de la lithiase, lesquels sont cités ?
- A. S'assurer que les examens échographiques sont effectués
 - B. Vérifier la cholécystographie réalisée 6 mois après le début du traitement
 - C. Ignorer les examens radiologiques
 - D. S'assurer des conditions nécessaires à l'efficacité du traitement
 - E. Aucune vérification nécessaire
12. Quels éléments sont surveillés par l'infirmier au cours du traitement de la lithiase biliaire ?
- A. L'état nutritionnel
 - B. Les effets secondaires des médicaments
 - C. La fièvre et l'état de l'hypochondre
 - D. Les fonctions du foie
 - E. Aucun suivi nécessaire
13. Parmi les aliments à éviter dans le régime de la lithiase biliaire, lesquels sont cités ?
- A. Viande grasse
 - B. Poisson gras
 - C. Œufs
 - D. Ragoûts et sauces
 - E. Légumes verts
14. Quels mécanismes participent à la formation des calculs biliaires selon le cours ?
- A. Ralentissement de la circulation de la bile
 - B. Stase biliaire
 - C. Infection surajoutée
 - D. Hypercalcémie alimentaire excessive

E. Hyperhydratation

15. En cas de chirurgie pour lithiase biliaire compliquée, quels soins infirmiers sont mentionnés ?

A. Soins préopératoires

B. Soins peropératoires

C. Soins postopératoires comme pour les interventions du tube digestif

D. Aucun soin particulier requis

E. Soins identiques à une chirurgie cardiaque uniquement